

Información Paciente

Nombre : Wladimir Eduardo Rojas Rojas
Edad : 48a 0m 30d
Dirección : Federico Garcia Lorca 343

Rut : 13.485.296-8
Fecha Nacto: 06/01/1978
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 9837700
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 2641 1379

N° Epicrisis
471188

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto
Unidad de Egreso : Utim

Fecha Ingreso : 02/01/2026 20:16
Fecha Egreso : 05/02/2026 19:02

Días Estadía: 34

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea y edema

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS UTIM 05/02/2026

Nombre: Wladimir Eduardo Rojas Rojas
RUT: 13485296-8
Edad: 48
FI HSR: 02/01/2026
FI UPC: 03/01/2026
FI UTIM: 24/01/2026

ANTECEDENTES

- Médicos: ERC V etiología no precisada, en HD x FAV BI desde octubre 2019 (MJS Trinef 1° turno), diuresis residual 200 cc. HTA, consumo perjudicial de OH. Sin plan de trasplante hasta que cese consumo de OH. Obesidad.
- Quirúrgicos: Múltiples accesos vasculares (CHD y FAV con reparaciones y rescates numerosos). TEC en la infancia, plastía de estenosis venosa central (2022).
- Alergias: (-)
- Fármacos: rescato informacion de sistema: Clopidogrel 75 mg, hidralazina 50 mg cada 8 h, carvedilol 25-25 mg, furosemida 80 -80 mg, nifedipino 20-20 mg, carbonato de calcio x2 (alejado de comidas), cinacalcet 30 mg/día, phoslo x3 (con comidas), ácido fólico, complejo B mensual.
- Hospitalizaciones recientes: Numerosas por complicaciones de accesos vasculares o EPA. Agosto 2024 RA 2° neumonía por VRS y EPA. Trombosis de FAV protésca ESI en febrero 2025, manejada con trombectomía (14/02/25) y 2 stent. Ultima hospitalizacion agosto/25 por FAV disfuncional.
- Hábitos: TBQ (+) 1 cig/semanales, OH en descenso (1 destilado cada 2 semanas), drogas (+) THC, previamente PBC.

HISTORIA DE INGRESO

Paciente soporoso al momento de la evaluación. Información de antecedentes y anamnesis rescatado de sistema. Acude el 02/01 derivado desde centro de diálisis por cuadro de 3 días de edema generalizado, disnea progresiva, tos húmeda, febril, edema generalizado. Última diálisis 02.01.2026 por 2 hrs, mal tolerada, con tendencia a hipotensión. En SUA evoluciona con dificultad respiratoria, por lo que se decide intubar.

Estudio inicial:

Fecha Epicrisis : 05/02/2026 19:09

Fecha Última Actualización: 05-02-2026 19:09:09

Página 2 de 5

- TAC: Opacidad parenquimatosa de relleno alveolar con componente atelectásico en el lóbulo inferior derecho, probablemente determinada por un foco de neumopatía en evolución. Adenopatías mediastínicas e hiliares derechas, de carácter reactivo. Acentuada atrofia renal bilateral.

- Laboratorio: Ca 8.3, crea 10.15, Troponina I <10.0, BUN 45.7, PCR 389.6, TP 15.4, INR 1.24, TTPA 29.9, Hto 33.5, Hb 11.0, leuco 9.60, plaq 167, Na 140, K 4.67, Cl 102, GSV pH 7.342, CO2 39.5, HCO3 20.9, EBVT -4.8, Ácido láctico 19.8

- Cultivos: Panel viral respiratorio pendiente. PCR SARS CoV2 Muestra rechazada. HC(+) para cocos gram (+). Serología NR

El día 07/01 presenta PCR hipóxica en relación a desplazamiento de TOT, al volver de control de imágenes. Se mantiene sedado full x 48 hrs, y posteriormente, en el contexto de evidente mejoría de los parámetros ventilatorios, se inicia disminución de sedación para inicio de weaning. Autoextubado el 18/01, posteriormente se apoya con VNI.

Se traslada a UTIM el 24/01/26 para consolidar destete de O2, continuar tratamiento antibiótico.

LABORATORIO DE INGRESO UTIM

24/01: ALBUMINA 3.8 CA 9.7 CREA 6.31 BUN 23.9 GLUCOSA 84 MG 2 PT 7.6 PCR 75 ELP 141/4.7/106 GSV PH 7.2 PCO2 52 HCO3 24.5 HB 8.7 GB 8.140 PLT 407.000

MICROBIOLOGIA

20.01: líquido pleural: hemorrágico, amarillo, 50 células, glucosa 45mg/dl, proteínas 44 g/L, LDH 576, sin pH. gram NSOB; cultivo (P)

14.01: BGNPC (-), CAET (-)

14.01: punta CVC (-)

13.01: HC I/II (-)

11.01: Clostridium a/b/GDH: (-)

09.01: HC CVC (+) a los 4d S.epidermidis (R oxa)

08.01: CAET: (-)

03.01: HC/II: (-) Portación: (-) Covid: Muestra no apta.

02.01: HC I/II: 10hr Neumococo S: Ceftriaxona, PNC, Vanco. Panel Viral Respi: (-), VHB/C/VIH: (-)

IMÁGENES DE INGRESO

03/01 TAC TX: Opacidad parenquimatosa de relleno alveolar con componente atelectásico en el lóbulo inferior derecho, probablemente determinada por un foco de neumopatía en evolución. Se sugiere control evolutivo en 4 - 6 semanas, para documentar resolución. Adenopatías mediastínicas e hiliares derechas, de carácter reactivo. Acentuada atrofia renal bilateral.

15/01TAC TAP: Examen negativo para tromboembolismo pulmonar agudo.

Leve aumento de cuantía del derrame pleural derecho con áreas de loculación y componente cisural asociado a hipe r realce pleural este último hallazgo es de carácter indeterminado, el diagnóstico diferencial incluye un origen inflamatorio, cambios post instrumentalización podría tener similar morfología indispensable correlación clínica.

Disminución de cuantía del derrame pleural izquierdo.

Disminución en extensión de las opacidades condensantes en lóbulos inferiores y resolución de las atelectasias en llingula.

Aumento de volumen del músculo obturador interno derecho hallazgo nuevo con respecto a estudio previo, sin áreas categórica las hipodensas en su espesor, considerar un hematoma.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO A UTIM

PCR Hipóxico Reanimado con ROCS 2do ciclo en sinusal (06.01)

TOT desplazado en 26cm.

Shock Séptico Foco Pulmonar (02.01)

NAC ATS IV Bacteriemia por Neumococo a las 10hr (02.01)

Miocardopatía séptica en manejo

ERC en HD trisemanal

Antecedentes: HTA ERC HD hace 5 años, trisemanal lun - mie- vie por CHD izquierdo, anurico

EVOLUCION DURANTE SU ESTADIA HOSPITALARIA

Hemodinamia: Estable, sin gatillo transfusional, conservando taquicardia sinusal en contexto de delirium y estado constitucional. Mantuvo HDN estable. MNI.

Fecha Última Actualización: 05-02-2026 19:09:09

Página 3 de 5

Respiratorio: Ingres a con IRA parcial secundaria a NAC neumocócica, complicada con deterioro ventilatorio que requirió IOT/VMI y manejo en UPC. Presenta autoextubación tras 16 días en VMI, posterior dependencia fluctuante de O₂ y episodios de hipoventilación/retención de CO₂ por mal manejo de secreciones. Se extuba sin incidentes, consolida weaning, y se trasalda a UTIM, donde mantuvo bajos requerimientos de O₂ hasta 1 L por narciera, destacando atelectasias bilaterales residuales y NAC en resolución en TC del 02/02/26. Logra destete de O₂ el 04/02, con buena mecánica ventilatoria.

Infeccioso: Debuta con shock séptico de foco pulmonar por NAC neumocócica bacteriémica grave, tratado inicialmente con ceftriaxona EV dirigida a neumococo sensible, con respuesta parcial. Ante progresión radiológica donde se sospechó empiema en LID, se escaló a imipenem EV (desde 10/01) asociado transitoriamente a vancomicina (suspendida por cultivos negativos). Posteriormente, sospecha de empiema descartada por Cx Tórax y TAC 02/02 (neumonía en resolución y derrames pleurales en regresión); presentó nuevo peak febril el 30/01, con HC negativas, sospechando una traqueobronquitis como posible foco, aunque sin microbiología aislada, manejado con tazonam por 5 días (FT 05/02), en contexto de posible componente aspirativo, con buena respuesta clínica y descenso de PCR.

Nefrológico: ERC-HD, dializándose trisemanal. Última HD el 04/02. Se toma contacto con centro diálisis TRINEF para mantener HD habitual al alta.

Hematológico: AngioTAC de tórax (16/01) evidencia aumento de volumen del músculo obturador interno derecho, sugerente de hematoma. El 02/02 presenta descenso de Hb de 9,5 a 7,4, por lo que se solicita angioTAC de abdomen/pelvis y tórax ante sospecha de TEP por taquicardia sinusal persistente y re-control de dicho hematoma. Se planifica AngioTAC TAP el 05/02 a las 17:00 hrs previo al alta.

ETE: TAC de tórax evidencia CVC en yugular interna izquierda, con extremo distal en vena braquiocefálica y trombo no oclusivo en yugular interna; CVC retirado. No se anticoagula por hematoma en músculo obturador evidenciado al ingreso. Sin embargo, dado paciente en diálisis, requiere anticoagulación con antagonistas de vitamina K, pero alto riesgo de calcifilaxis. Dado indicación de anti-coagulación en este caso no es perentoria (trombo no oclusivo CVC YI), se desestima anticoagular. Pendiente estudio de imagen con AngioTAC TAP realizado el 05-02 sin embargo la imagen no llega a pelvis.

Neurológico/Psiquiátrico: Agitación psicomotora severa asociada a abstinencia de alcohol y otras drogas, que requirió manejo en UTIM con lorazepam, haloperidol, quetiapina y Precedex, además de contención física por agresividad. Por sobre-sedación se suspendió tratamiento el 30/01, con mejoría del sensorio, aunque persistió delirium; TC cerebral (02/02) sin hallazgos agudos. Actualmente más tranquilo y orientado, sin contenciones, en manejo con antipsicóticos a dosis bajas.

Rehabilitación: Inicialmente con NE con agua libre y régimen cero vía oral. Presenta mal manejo de secreciones orofaríngeas. Se retira SNG el 04/02, se autoriza régimen licuado más líquidos claros. Se indica mantener FNA al alta con UHD.

DIAGNOSTICOS DE EGRESO

1. Compromiso de Conciencia:
 - Insuficiencia respiratoria aguda, parcial.
 - IOT-VMI (02-18/01/26).
 - Síndrome edematoso.
2. Shock Séptico: Recuperado.
 - NAC LID + bacteriemia por neumococo.
 - Derrame pleural bilateral (derecho loculado).
3. PCR hipóxico 2° desplazamiento del TOT.
 - Autoextubado (18/01/26).
4. Delirium hiperactivo:
 - Abstinencia OH +/- Policonsumo.
5. Hematoma obturador interno.
6. Trombo no oclusivo en la vena yugular interna izquierda.
7. Atelectasias subsegmentarias bilaterales.
8. Síndrome Febril, sin foco precisado.
 - Obs. Traqueobronquitis, sin microbiología aislada (aspirativa).
9. Antecedentes:
 - HTA.
 - ERC-HD.

Fecha Epicrisis : 05/02/2026 19:09

Página 3 de 5

Fecha Última Actualización: 05-02-2026 19:09:09

Página 4 de 5

- Tunelizado SC izquierdo.
- FAV BI disfuncional.
- OH activo.

Diagnóstico de Egreso

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente se mantiene en buenas condiciones generales con hemodinamia estable. Sin nuevas interurrencias. Sin nuevos episodios de agitación. En plan de alta con UHD.

Plan Post Alta

INDICACIONES DE ALTA

Se indica alta con UHD para KNT motora y Fonoaudiología

MEDIDAS GENERALES

- Reposo relativo asistido
- Régimen licuado y líquidos claros, asistido, pausado, sentado
- Kinesioterapia motora, respiratoria diaria
- Fonoaudiología 2 a 3 veces por semana

MEDICAMENTOS

- Berodual 2 puff cada 6 horas por 5 días con AEC luego SOS
- Lactulosa 20cc cada 8 horas VO
- Risperidona 0.5mg cada 12 horas VO
- Paracetamol 500mg 2 comprimidos cada 8 horas SOS si dolor

EVALUAR CONTINUIDAD DE FARMACOS DE USO CRONICO (PENDIENTE QUE FAMILIARES EXPONGAN LISTA DE MEDICAMENTOS QUE USABA EN DOMICILIO)

SUSPENDER

Antihipertensivos

CONTROLES

Control con Nefrología al alta. (Previamente en controles CDT)
Control con Cirugía Vascular al alta. (Previamente en controles CDT)
Pendiente FAV Protésica.

Mantener HD en Centro TRINEF de forma habitual (Se toma contacto con centro, se indica acudir sábado 07/02/26 en primer turno)

Control en APS/Consultorio en Programa salud mental para evaluación por médico y psicólogo por antecedente de abuso sustancias y ajuste antipsicóticos

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Bajo En Sodio, Potasio Y Fosforo

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 05/02/2026 19:09

Página 4 de 5

Fecha de Impresión : Jueves, 26 de Marzo de 2026 00:05

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 05-02-2026 19:09:09

Página 5 de 5



Vania Fernanda Bec Cari Gormaz

Becado/Residente



Jhony Gomez Mendoza

Médico Tratante (Staff)

INTERNO